

Procedimento Operacional Padrão - POP

Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 1/11	Anexo 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Procedimento: Aplicação da bota de Unna

Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerência da Atenção Primária e Gerência de Serviços Especializados

Serviço(s) executantes: Atenção Primária e Serviços Especializados

Profissionais Executantes: Enfermeiros e técnicos em enfermagem

Objetivo(s): Garantir a padronização, segurança e eficácia na aplicação da bota de Unna pelos profissionais da rede de atenção à saúde.

Recursos necessários:

- Pia com água;
- Sabão;
- Luva de procedimento;
- Bota de unna (bandagem impregnada com óxido de zinco)
- Gazes estéreis
- Soro fisiológico,
- Agulha 40x12
- Atadura de crepom
- Tesoura limpa
- Solução de PHMB
- Pinças estéreis ou luvas estéreis
- Lixeira com saco branco
- Bacia/cuba (se necessário)
- Lâmina de bisturi (se necessário)
- EPI (óculos, avental e máscara)
- Esparadrapo
- Soluções, medicamentos e/ou coberturas conforme característica da lesão;

DEFINIÇÃO

As terapias contensivas e compressivas são o método mais recomendado para o tratamento de pessoas com úlceras venosas e linfedema, tendo como princípio básico a melhora do retorno venoso. Pode ser dividida em inelástica (bota de Unna) e elásticas (meias e ataduras elásticas) (DISSEMOND et al., 2016).

A bota de unna corresponde a uma cobertura no formato de bandagem de contenção, impregnada principalmente com óxido de zinco, que apresenta sua ação



Procedimento Operacional Padrão - POP					
Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 2/11	Anexo 00

durante o movimento do membro inferior afetado, favorecendo o retorno venoso (BORGES, 2011).

Importante: Uma vez que o usuário tenha apresentado a úlcera venosa, seus cuidados serão permanentes, ou seja, sempre haverá a necessidade de cuidados, mesmo após a cicatrização, como a utilização de uma terapia compressiva (por exemplo, as meias elásticas). (RIO DE JANEIRO, 2025)

DESCRIÇÃO

1. Aplicação da bota de unna

Passo 01. Preparação do Ambiente e do Paciente:

- Assegurar que o ambiente esteja limpo e confortável;
- Explicar o procedimento e sua finalidade ao paciente e familiares, obtendo seu consentimento;
- Conferir a prescrição médica ou do enfermeiro Estomaterapeuta;
- Identificar a pessoa perguntando seu nome completo antes de executar o procedimento;
- Oferecer privacidade à pessoa.

Passo 02. Reunir o material indicado para o procedimento:

- Pacote de curativo simples;
- Soro fisiológico;
- Luva de procedimento;
- Avental;
- Óculos;
- Cobertura primária;
- Bota de unna;
- Gaze rolo;
- Atadura;
- Fita microporosa.



Procedimento Operacional Padrão - POP					
Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 3/11	Anexo 00

Passo 03. Higienizar as mãos e usar os EPI 's necessário para o procedimento, conforme orientado no Manual de Biossegurança disponível no Processo SEI nº 23.0.177095-2.

Passo 04. Remoção de Curativos Anteriores:

- Remover cuidadosamente, se houver curativos ou botas anteriores, conforme descrito no POP SES.DGE.DAP nº 63 - Como Realizar a Técnica de Curativo em Lesões Abertas.
- Mensurar com régua impressa (disponível no SEI - 25.0.244782-2 - SES.DGE.DAP nº 63) exclusiva para esse fim, as dimensões da lesão (altura, largura e profundidade), traçando uma linha na maior extensão vertical e maior extensão horizontal. Onde a linha vertical é o comprimento (céfalo caudal) e a linha horizontal é a largura (esquerda para direita) com cuidado de não tocar a régua no leito da lesão;
- Observar a ferida com relação ao aspecto da lesão, tecido do leito, aspecto da margem, tamanho, exsudato (tipo e quantidade), pele ao redor da lesão (4-20 cm) e presença de edema, hiperemia, calor ou dor local e odor;
- Registrar no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech) as mensurações em cm e observações com relação a ferida, para comparações posteriores.

Passo 5. Realizar a limpeza da lesão, conforme descrito no POP SES.DGE.DAP nº 63 - Como Realizar a Técnica de Curativo em Lesões Abertas.

Importante: A atuação do técnico em enfermagem está restrita aos itens 01 a 05 deste POP. Devendo chamar o enfermeiro(a) para a execução e/ou supervisão dos passos seguintes.

Passo 6. Aplicar cobertura primária, conforme característica da lesão e periodicidade de troca, conforme protocolo vigente.

Passo 7. Aplicação da Bota de Unna:

- Solicitar ao paciente que mantenha o pé em um ângulo de 90º graus em relação à perna. O que fará com que o curativo seja mais confortável durante o caminhar;



Procedimento Operacional Padrão - POP

Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 4/11	Anexo 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

- Iniciar a aplicação da bandagem impregnada com óxido de zinco na região do pé, com o paciente em posição adequada, deixando os dedos expostos;
- Realizar o enfaixamento Bota de Unna de forma espiral ou cruzada iniciando acima dos dedos na região metatarso, mantendo o pé e o calcanhar em ângulo reto e, continuar até que chegue a 3 cm abaixo do joelho;
- Envolver com 50% a 75% de sobreposição em cada fileira, sem apertar e sem deixar abertura ou enrugamento;
- Cruzar a faixa em sentido diagonal no dorso do pé. Após realizar até três vezes o enfaixamento em oito no tornozelo, seguir cobrindo o calcanhar, podendo enfaixar até duas voltas na região do calcâneo, em posição de dorsiflexão;
- Manter o pé apoiado na maca, de modo que esta musculatura fique relaxada; ao chegar à altura da panturrilha;
- Enrolar a bandagem em espiral ou cruzada “**em oito**” ou “**em x**”, em sentido único distal proximal, aplicando progressivamente até a tuberosidade tibial (até cerca de 2 cm abaixo da fossa poplíteia). Envolver com 50 a 75% de sobreposição em cada fileira;
- Fazer camada terciária de cobertura absorvente (gaze, chumaço), após a aplicação da Bota de Unna, se houver lesão exsudativa.

Importante:

- Nunca volte o enfaixamento da Bota para a região distal (para baixo), corte o restante da Bota ao chegar a 2 cm abaixo do joelho.
- A bandagem em espiral resulta em duas camadas de material;
- A bandagem em “x” resulta em quatro camadas de material, com pressão e rigidez correspondentemente maiores.

Importante: Trocar Bota de Unna a cada 3 - 7 dias, de acordo com a quantidade de exsudato. Não deixar a troca a cada 7 dias se ferida apresentar bastante exsudação (a permanência dependerá da quantidade de exsudato).

Passo 8. Fixação e Proteção:

- Envolver o membro com uma atadura de crepe para proteger a bandagem e fornecer compressão adicional;



Procedimento Operacional Padrão - POP					
Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 5/11	Anexo 00

- Fixar a extremidade da atadura com esparadrapo ou outro meio adequado.

OBJ **Passo 9.** Verificação da Circulação:

- Verificar sinais de comprometimento circulatório, como alteração na coloração, temperatura ou presença de dor intensa, após a aplicação.

Passo 10. Finalizando o procedimento:

- Descartar o material utilizado, conforme disposto no Manual de Biossegurança, Processo SEI nº 23.0.177095-2;
- Higienizar as mãos conforme POP – Rotina SES.ENF nº 23, Processo SEI nº 23.0.177095-2, ao final de todo procedimento.

2. Orientações ao Paciente

- Entregar cópia da orientação ao paciente por escrito, disponível em prescrição live (Orientações) no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech) (APÊNDICE 01);
- Orientar o paciente para elevar a perna quando estiver sentado, movimentar tornozelo e estimular a caminhar;
- Orientar fazer repouso em decúbito dorsal 30 minutos pela manhã e tarde;
- Observar sinais de complicações, como dor intensa, formigamento, inchaço excessivo ou alterações na coloração dos dedos, e reportar imediatamente à equipe de saúde;
- Orientar não retirar curativo em casa e retornar para reavaliação conforme agendamento ou se houver qualquer intercorrência;
- Suspender cobertura em caso de alergia ao produto.

3. Registro do Procedimento

- Registrar no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech) do paciente: Data e hora da aplicação, Condições da lesão antes da aplicação, descrição do procedimento realizado, orientações fornecidas ao paciente;
- Utilizar Códigos de **CIAP - S97** – Úlcera crônica de pele;
- Registrar código do procedimento conforme tabela SIGTAP (Tabela 1):



Procedimento Operacional Padrão - POP

Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 6/11	Anexo 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Tabela 1. Procedimento (código SIGTAP)

03.01.10.028-4 - Curativo simples
03.01.10.027-6 - Curativo especial
04.01.01.001-5 - Curativo grau ii c/ ou s/ debridamento
03.01.01.031-5 - Teleconsulta por profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)
03.01.01.004-8 - Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)
99980152 - PM Entrega de materiais para uso domiciliar. (quando fizer entrega de material para troca da atadura)

(Elaboração: USD/NGQ, 2026)

4. Monitoramento e retorno

- A troca da primeira bota de unna aplicada pelo enfermeiro(a) estomaterapeuta ou o Médico(a) deverá ser realizada na APS em 4 a 5 dias, seguindo as orientações descritas no encaminhamento.
- O retorno com o enfermeiro(a) estomaterapeuta ou o Médico(a) poderá ocorrer em 7 dias após a sua primeira aplicação, se caso houver a necessidade de avaliação dos mesmos.
- O enfermeiro(a) estomaterapeuta de referência irá monitorar a evolução da ferida através da solicitação dos insumos necessários conforme descrito no memorando SEI 0021477404 que posteriormente será solicitado ao CAME conforme descrito no SEI - 25.0.054414-6.
- Suspende cobertura em caso de alergia ao produto.
- Programar trocas do curativo secundário conforme necessidade pela quantidade de exsudato.

5. Alta da Bota de Unna

- A alta da terapia com Bota de Unna deve ser concedida quando a ferida estiver



Procedimento Operacional Padrão - POP					
Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 7/11	Anexo 00

totalmente epitelizada, caracterizando alta por cicatrização.

- Após esse momento, o enfermeiro capacitado está autorizado a prescrever a terapia compressiva com meias de compressão, caso não haja prescrição prévia pelo cirurgião vascular/e ou enfermeiro assegurando a continuidade do cuidado e a prevenção de recidivas da úlcera de membros inferiores.
- Caso o paciente se recuse a seguir com a terapia, o profissional deve registrar em prontuário.

6. Observações

- No caso de lesões mistas a Bota de Unna poderá ser realizada desde que indicada pelo especialista (médico vascular ou enfermeiro do estomaterapeuta) que irá avaliar o ITB (índice tornozelo-braço) com auxílio do Doppler vascular para verificação do grau de comprometimento arterial.
- Na presença de sujidade na atadura secundária e nas gazes as mesmas podem ser trocadas. Após a primeira colocação agendar retorno após 96 horas para reavaliação na APS.
- Orientar e avaliar sinais de alerta como piora da dor, cianose de extremidades, formigamento, aumento da temperatura ao toque, aumento do odor e piora do edema.
- As demais trocas devem permanecer em até 7 dias ou antes de acordo com a necessidade (frouxidão da bota, se estiver molhado), assim como o curativo secundário deve ser trocado diariamente ou conforme a quantidade de exsudato.
- Se o paciente precisar remover a Bota em casa, ela deverá ser desenrolada. Sugere-se que para isso a perna seja colocada na água (no banho de chuveiro ou bacia), a Bota “amolecerá” e a sua remoção será facilitada.



Procedimento Operacional Padrão - POP					
Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 8/11	Anexo 00

APÊNDICE 01

ORIENTAÇÕES DURANTE O USO DA BOTA DE UNNA

Elaborado por Enf Andressa Seer

1. Movimentar o pés com movimentos “vai e vem” 2 a 3 vezes ao dia, se possível;
2. Manter os pés elevados por, pelo menos 30 minutos ao dia - deitar e elevar os pés
** não adianta elevar enquanto está sentado!!**;
3. Se sentir dor, fazer os movimentos descritos acima, se não melhorar procurar a UBSF ou PA;
4. Sempre que possível, deitar e elevar as pernas;
5. Caminhar sempre que possível;
6. Evitar permanecer de pé em um único lugar ou sentado durante longos períodos com as pernas dependuradas;
7. Sinais de “**ALERTA**”: DEDOS DOS PÉS ROXOS, PÁLIDOS OU AZULADOS, INCHAÇO ACIMA DO CURATIVO, DOR INTENSA, FALTA DE SENSIBILIDADE NOS DEDOS DOS PÉS;
8. A Bota de Unna deve ser mantida seca: Para tomar banho, a perna deve ser embrulhada em plástico, papel filme, saco de lixo, entre outros;
9. Não tirar em casa, somente se sinais de alerta mencionados acima!!! (se precisar tirar, molhar antes);
10. Informar-se: dor crescente, vermelhidão se espalhando pelas pernas acima ou aos dedos dos pés, sensação de calor nas pernas ou aumento de temperatura ao toque, aumento de odor.



Procedimento Operacional Padrão - POP

Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 9/11	Anexo 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APS - Atenção Primária à Saúde;

CAME - Central de Abastecimento de Materiais e Equipamentos;

CIAP - Classificação Internacional de Atenção Primária;

cm - Centímetro;

DGE - Diretoria de Gestão Estratégica;

ENF - Enfermagem;

EPI - Equipamento de Proteção Individual;

PA - Pronto Atendimento;

POP - Procedimento Operacional Padrão;

SEI - Sistema Eletrônico de Informação;

SES - Secretaria Municipal de Saúde;

SIG-SaudeTech - Sistema Integrado de Gestão SaudeTech (Olostech);

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS;

UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família.

REFERÊNCIAS

BORGES, E.L.; LIMA, V.L.A.N. **Feridas: como tratar**. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Rubio, 2024. 400 p

BORGES, E. **Feridas: úlceras dos membros inferiores**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

Cardoso LV, Godoy JMP, Godoy MFG, Czorny RCN. **Compression therapy: Unna boot applied to venous injuries: an integrative review of the literature**. Rev Esc Enferm USP. 2018;52:e03394. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S1980-220X2017047503394>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. **Parecer Técnico Coren/SP 007/2013: Competência e capacitação para realização de curativo bota de Unna**. Disponível em: <https://portal.corensp.gov.br/wp-content/uploads/2013/07/parecercorensp20137pdf>. Acesso em 11/08/2025.

COFEN. Anexo da Resolução COFEN n.º 0567/2018. **Regulamento da atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas**. Brasília (DF), 2018. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/ANEXO-RESOLU%C3%87%C3%83O-567-2018.pdf>. Acesso em: 11/08/2025.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Parecer de Câmara Técnica n.º 04/2016/CTAS/COFEN. — Conselho Federal de Enfermagem**. Brasília (DF), 2016.



Procedimento Operacional Padrão - POP

Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 10/11	Anexo 00
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

Disponível em: http://www.cofen.gov.br/parecer-no-042016ctascofen_45837.html.
Acesso em: 11/08/2025.

DISSEMOND, Joachim et al. **Terapia compressiva em pacientes com úlceras venosas** n. Journal of german society of dermatology, [S. l.], p. 1-16, 30 out. 2016.
Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddg.13091>. Acesso em: 3 out. 2022.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. **FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM**. Tradução SALLES, Adilson Dias, et al. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Prefeitura Municipal de Criciúma, 2021. Todos os direitos reservados à Prefeitura Municipal de Criciúma. www.criciuma.sc.gov.br. Material produzido pela Equipe Técnica/Criciúma em parceria com Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva [Mestrado Profissional], da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Rio de Janeiro (Prefeitura). Secretaria Municipal de Saúde **Cuidado integral à pessoa com úlcera venosa : aplicação de bota de unna na Atenção Primária** / Prefeitura do município do Rio de Janeiro. -- 2. ed. -- Rio de Janeiro : Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2025.

São Paulo (Cidade). Secretaria da Saúde. **Manual técnico: normatização das rotinas e procedimentos de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde** / Secretaria da Saúde, Coordenação da Atenção Básica. 2. ed. - São Paulo: SMS, 2016. 292 p. – (Série Enfermagem)

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro **Cuidado integral à pessoa com úlcera venosa: aplicação de bota de unna na atenção primária** /Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. -- Rio de Janeiro, RJ : Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2023.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 Mayra Helena Kock Andressa Seer	2026 Juliana Antunes Safanelli Cibely Schipitoski Borges	2026 Grasiela Florêncio Medeiros Sayonara Salete Zuchetti

Relação de documentos disponíveis em [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#)

- Manual de Biossegurança
- POP SES.DGE.DAP nº 63 - Como Realizar a Técnica de Curativo em Lesões Abertas



Procedimento Operacional Padrão - POP

Emissão 08/04/2026	Próxima Revisão 08/04/2028	POP.SES.RAS.ENF.001	Versão nº 01	Página 11/11	Anexo 00
------------------------------	--	----------------------------	------------------------	------------------------	--------------------

Relação de documentos disponíveis via Sistema Eletrônico de Informações (SEI):

- **POP Rotina SES.ENF nº 23 - Higienização das Mãos**, SEI nº 23.0.177095-2
- **Solicitação de insumos**, SEI nº 25.0.054414-6

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 26.0.104050-0

Site da Prefeitura: [Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde](#)

